

GUIDE ABRÉGÉ DE SURVEILLANCE DES MAPI

EN ROUTINE ET LORS D'UNE ÉPIDÉMIE EBOLA

à l'intention des points focaux et du personnel des hôpitaux de référence

SOMMAIRE

	<i>page</i>
Tableau synoptique de la surveillance des MAPI	2
Événements à notifier	3
Tri des patients à l'entrée des formations sanitaires	3
Circuit de surveillance des MAPI en routine	4
Circuit de surveillance des MAPI lors d'une épidémie à virus Ebola	5
Notifier un évènement indésirable par open data kit (ODK)	6
Validation des notifications par le point focal de district	6
Attribution de codes	7
Gestion des MAPI non graves par le notificateur	8
Gestion des MAPI graves par le notificateur	8
Investigation	9
Orientations pour le laboratoire de l'hôpital de référence	10
Prise en charge des MAPI graves à l'hôpital de référence	12
Répertoire d'adresse des contacts directs dans la surveillance des MAPI	16

TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA SURVEILLANCE DES MAPI

FORMATION SANITAIRE	POINT FOCAL DISTRICT	POINT FOCAL DÉPARTEMENT	EQUIPE NATIONALE MAPI
FS1a. Rendre les fiches de notification disponibles : -dans toutes les formations sanitaires -et sur les sites de vaccination FS1b. Collecter les notifications	PFd1a. Valider la qualité des notifications PFd1b. Enregistrer via ODK les notifications dans la base de données nationale PFd1c. Enregistrer les notifications dans la fiche de synthèse et envoyer photo de la fiche de synthèse par WhatsApp au PFD	PFD1a. Evaluer le remplissage correct des fiches de synthèse PFD1b. Vérifier auprès de l'équipe nationale MAPI que chaque cas de MAPI est enregistré dans la base de données nationale	ENM1a. Suivre la transmission des fiches de notifications ENM1b. A l'aide des fiches de notifications, compléter les informations rentrées via ODK dans la base de données nationale ENM1c. Nettoyer la base de données sous ODK et exporter les données vers Vigiflow
FS2a. Faire le tri à l'entrée du patient dans la formation sanitaire -FS2a ₁ . Si Ebola suspecté, transférer au Centre de Traitement Ebola -FS2a ₂ . Si MAPI suspecté, évaluer sa gravité FS2b. Générer l'alerte si MAPI grave	PFd2a. Transférer l'alerte au point focal de département et au directeur du district sanitaire PFd2b. Appeler le patient (ou ses accompagnants) pour faire le suivi du transfert à l'hôpital de référence	PFD2a. Transférer l'alerte à l'équipe nationale MAPI et au Directeur Départemental de la Santé PFD2b. Appeler le service identifié de l'hôpital de référence pour apprêter le lit et initier le processus d'admission PFD2c. Suivre la référence du patient et au besoin mobiliser l'ambulance. PFR2d. L'hôpital de référence fait le tri Ebola à l'admission (cf FS2a ₁) PFD2e. Suivre le remplissage correct du dossier médical en cours d'hospitalisation y compris la réalisation et l'envoi des résultats d'analyses et photocopier le dossier médical à l'exéat (à transmettre à l'équipe nationale MAPI).	ENM2a. Rédiger le résumé des cas à partir du dossier médical pour présentation à la réunion du comité des experts ENM2b. Organiser les réunions du comité des experts et en tenir la mémoire écrite
	PFd3a. Rechercher les fiches de notification des MAPI sur la base du nombre de MAPI signalé sur les fiches de pointage des vaccinateurs.		ENM3a. Faire l'analyse du profil de sécurité du vaccin à partir de la base de données nationale ENM3b. Faire l'analyse de performance du système de surveillance à partir de la base de données nationale et des données de supervision ENM3c. Rédiger et communiquer le rapport de surveillance

Notification des MAPI

Soins hospitaliers pour les cas suspects de MAPI graves

Analyse et utilisation des données

EVENEMENTS A NOTIFIER



Décès inexpliqué Etat de choc Fièvre extrême Lésions buccales
Vasculite cutanée Abscesses au point d'injection Dermate, Eruption cutanée
Lésions vésiculaires de la peau Convulsions persistantes ou fébriles
Arthralgie, Arthrite Altération/dépression de la conscience Trouble du comportement
Douleur au point d'injection et fièvre Maux de tête et symptômes pseudo grippaux
Réduction transitoire des lymphocytes, neutrophiles et plaquettes sans manifestation clinique

TRI DES PATIENTS A L'ENTREE DES FORMATIONS SANITAIRES

PREMIERS SYMPTÔMES DE LA MALADIE À EBOLA

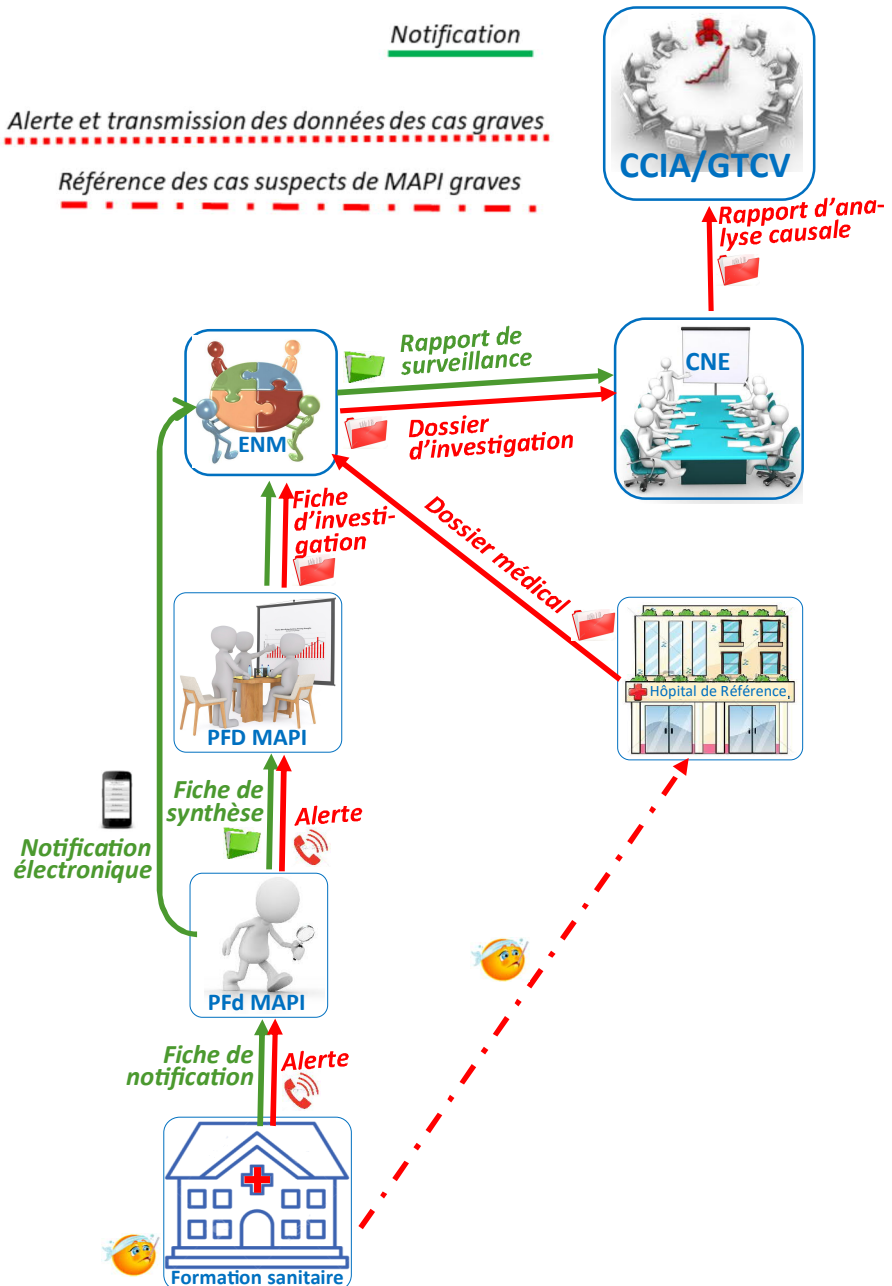
Les symptômes peuvent apparaître entre 2 et 21 jours après l'exposition

- Fièvre
- Douleurs d'estomac
- Maux de tête
- Saignements ou contusions inexpliqués
- Diarrhée
- Douleurs musculaires

Un cas d'Ebola doit être suspecté dans le cas de toute personne vivante ou morte,

- souffrant ou ayant souffert d'une forte fièvre soudaine et ayant été en contact avec un cas suspect, probable ou confirmé d'Ebola,
- ou toute personne présentant une forte fièvre soudaine et présentant au moins trois des symptômes suivants : maux de tête, vomissements, anorexie / perte d'appétit, diarrhée, léthargie, douleurs à l'estomac, douleurs articulaires ou articulaires, difficulté à avaler, difficultés respiratoires, hoquet ;
- ou toute personne présentant un saignement inexplicable,
- ou Toute mort soudaine et inexplicable.

Circuit de surveillance des MAPI en routine

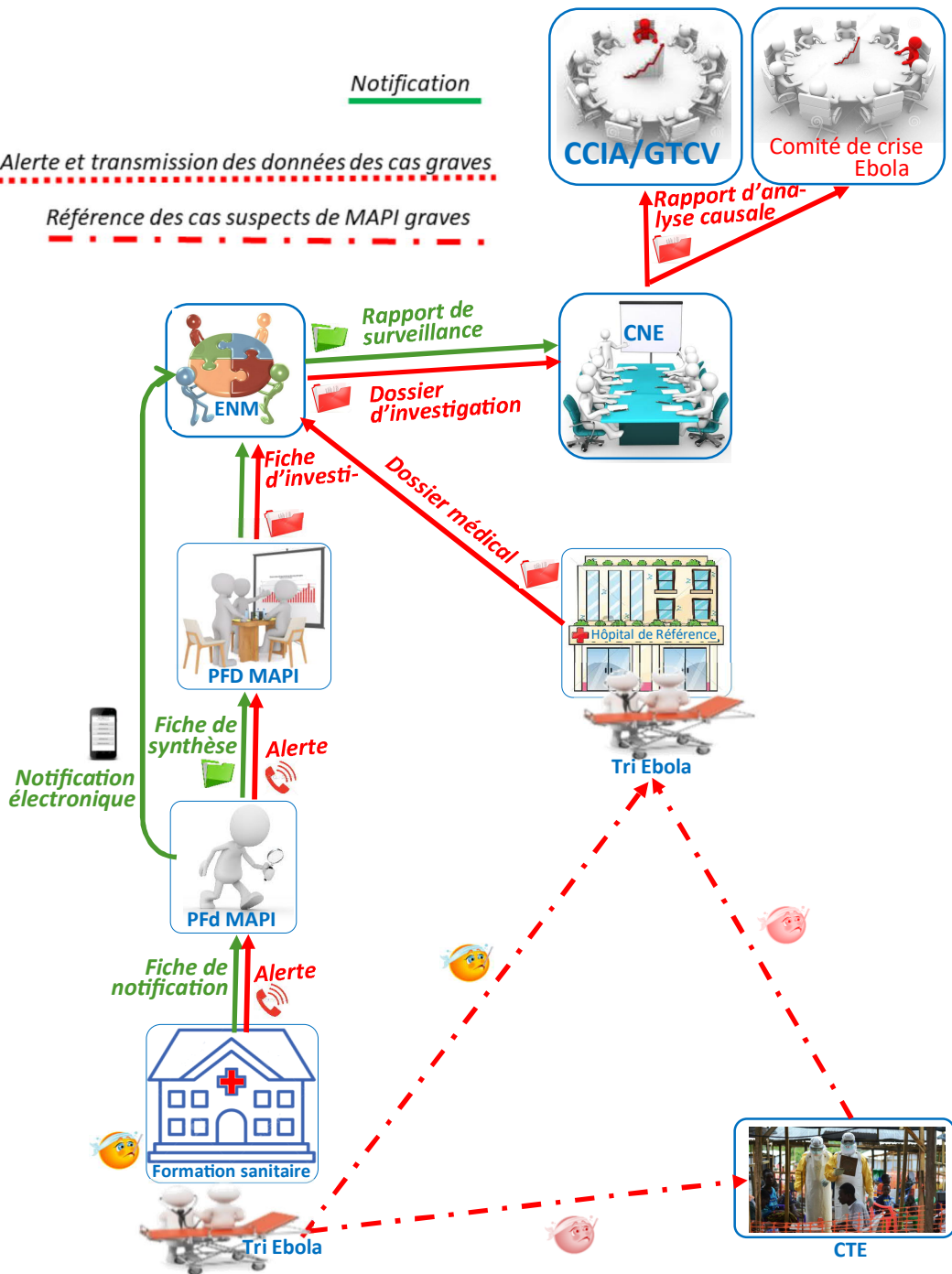


Circuit de surveillance des MAPI lors d'une épidémie à virus Ebola

Notification

Alerte et transmission des données des cas graves

Référence des cas suspects de MAPI graves



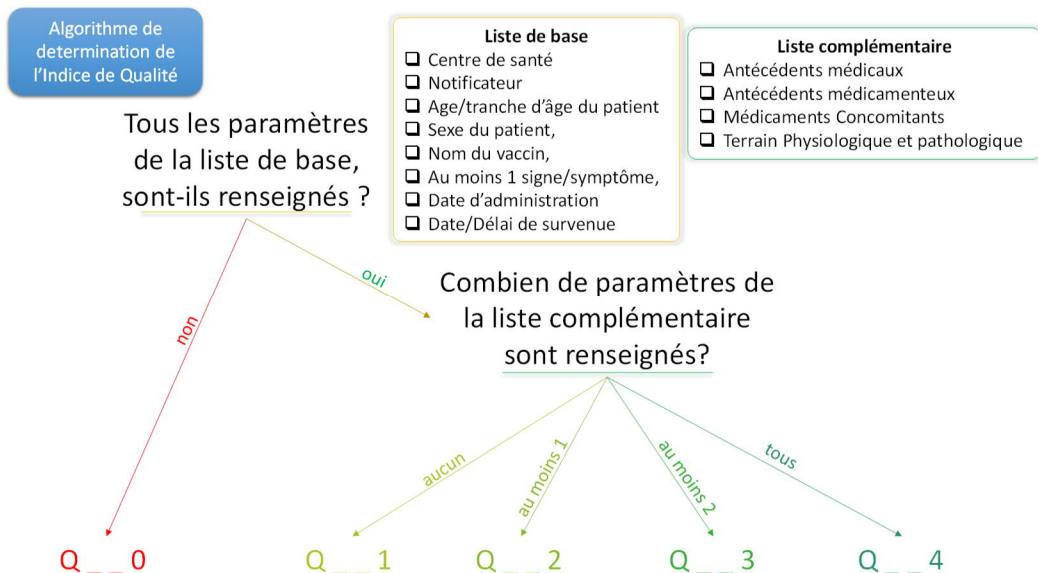
NOTIFIER UN EVENEMENT INDESIRABLE PAR OPEN DATA KIT (ODK)

1. Télécharger l'application ODK COLLECT dans le google play store.
2. Ouvrir l'application
3. Ouvrir MODIFIER LES PARAMETRES
(les 3 points verticaux en haut à droite)
4. Choisir SERVEUR
5. Entrer comme URL : <http://esurv.afro.who.int/whocongo>
6. Retourner à la page d'accueil de l'application
7. Choisir TELECHARGER UN FORMULAIRE VIERGE (au bas)
8. Dans la liste de formulaires qui s'affiche, désélectionner tout sauf AEFI_MAPI
9. Choisir TELECHARGER LA SELECTION (en bas à droite)
10. Retourner à la page d'accueil



Chaque fois qu'il y'a un événement indésirable à notifier, choisir REMPLIR UN FORMULAIRE. Ensuite il est possible d'EDITER UN FORMULAIRE déjà rempli ou d'ENVOYER LE FORMULAIRE FINALISE

VALIDATION DES NOTIFICATIONS PAR LE POINT FOCAL DE DISTRICT



Q0 : La notification n'est pas exploitable.

Q1, Q2, Q3 Le point focal de district appelle le notificateur pour compléter la notification dans le but de la rapprocher de Q4.

Attribution des codes uniques par le point focal de district

Code unique = PREFIXE DE CODE - PV19 - numéro de série

BOUENZA

LOUTETE	CNG-BOU-LOU-
MADINGOU	CNG-BOU-MAD-
MOUYONDZI	CNG-BOU-MOY-
NKAYI	CNG-BOU-NKA-

BRAZZAVILLE

BACONGO	CNG-BZV-BAC-
DJIRI	CNG-BZV-DJI-
MADIBOU	CNG-BZV-MDB-
MAKELEKELE	CNG-BZV-MAK-
MFILOU	CNG-BZV-MFI-
MOUNGALI	CNG-BZV-MOU-
OENZE	CNG-BZV-OUE-
POTO-POTO	CNG-BZV-POT-
TALANGAI	CNG-BZV-TAL-

NIARI

DOLISIE	CNG-NIA-DOL-
KIBANGOU	CNG-NIA-KIB-
MOSSENDJO	CNG-NIA-MOS-



CUVETTE

ALIMA	CNG-CUV-ALI-
MOSSAKA LOUKOLELA	CNG-CUV-MOS-
OWANDO	CNG-CUV-OWA-

CUVETTE-OUEST

ETOUMBI	CNG-CUO-ETO-
EWO	CNG-CUO-EWO-

LEKOUMOU

SIBITI CNG-LEK-SIB-

SANGHA

OUESSO CNG-SAN-OUE-

LIKOUALA

IMPFONDO CNG-LIK-IMP-

KOUILOU

HINDA-MVOUTI	CNG-KOU-HIN-
MADINGO-KAYES	CNG-KOU-MDK-

POINTE-NOIRE

LOANDJILI	CNG-PNR-LOA-
LUMUMBA	CNG-PNR-LUM-
MONGO POUKOU	CNG-PNR-MON-
MVOUMVOU	CNG-PNR-MVO-
NGOYO	CNG-PNR-NGO-
TCHIAMBA NZASSI	CNG-PNR-TCH-
TIE-TIE	CNG-PNR-TIE-

PLATEAUX

ABALA	CNG-PLA-ABA-
DIAMBALA-LEKANA	CNG-PLA-DJA-
GAMBOMA	CNG-PLA-GAM-

POOL

GOMA TSÉTSÉ	CNG-POO-GOM-
IGNIÉ NGABÉ MAYAMA	CNG-POO-IGN-
KINDAMBA	CNG-POO-KDB-
KINKALA-BOKO	CNG-POO-KIN-
MINDOULI	CNG-POO-MIN-

GESTION DES MAPI NON GRAVES PAR LE NOTIFICATEUR

Les réactions locales surviennent dans les 24h et disparaissent dans les 2 ou 3 jours parfois sans traitement

- Gonflement au point d'injection: légère réaction inflammatoire au point d'injection, n'atteignant pas les articulations sus et sous-jacentes.
- Douleur au point d'injection: réaction douloureuse et sensible au point d'injection.

Traitement: Paracétamol per os (15 mg/kg toutes les 6 heures)

La fièvre modérée (38°5C).

Traitement: Paracétamol per os (15mg/kg toutes les 6 heures)

Si la fièvre persiste au-delà de 24h → se référer à la prise en charge des MAPI graves

Les réactions allergiques: éruption survenant 7 à 10 jours après la vaccination, pouvant persister jusqu'à 2 jours.

Traitement: Hémisuccinate d'hydrocortisone en IV lente (10mg/kg)

La conduite à tenir devant toute MAPI non grave est de traiter, notifier et conseiller au patient de revenir si les symptômes persistent.

GESTION DES MAPI GRAVES PAR LE NOTIFICATEUR

Une MAPI est grave pour l'une ou l'autre des conditions suivantes :

- Décès ou mise en jeu du pronostic vital
- Nécessité d'hospitalisation ou de prolongation d'hospitalisation
- Incapacité ou invalidité persistante ou effet sur le produit de conception



ALERTER en appelant par téléphone le superviseur d'équipe et le point focal MAPI

STABILISER le patient ; que l'infirmier prenne sa tension, son pouls et sa température et s'assure qu'il n'est pas en danger de mort



1 2

REFERER, en appelant l'hôpital de référence et envoyant le malade dans le service apprêté pour l'accueillir. Demander une ambulance au besoin



3 NOTIFIER en remplissant une fiche de notification des événements indésirables et la remettant au superviseur pour le point focal MAPI





Quelles MAPI notifiées investiguer ?

L'investigation est nécessaire si la MAPI :

- est grave
- fait partie d'une grappe
- relève d'un signal suspect
- est une erreur de vaccination suspectée
- apparaît sur la liste des MAPI appelant une enquête ou
- est un motif de préoccupation important pour la communauté les parents ou le public

Toute investigation doit être lancée dans les 24 à 48heures suivant la première notification du cas.

Constituer une équipe d'investigation

L'équipe d'investigation doit être mise en place par le Directeur Départemental de la Santé et doit comprendre sans être limité à :

- ☞ le point focal Départemental MAPI,
- ☞ le point focal de district MAPI,
- ☞ le chargé PEV du département,
- ☞ le médecin en charge du cas,

Comment collecter les données

Utiliser la fiche d'enquête

Obtenir des informations directement auprès du patient ou de la famille, de la communauté

Obtenir des informations auprès de l'équipe de vaccination et de l'équipe soignante ou au moyen des archives disponibles : poser des questions et observer le service en action si possible

Recueillir des échantillons du vaccin, du diluant et des intrants.

Rapport d'investigation

Décrire la méthode de travail

Constituer un dossier d'investigation comprenant :

La fiche d'enquête remplie

La fiche de notification

La photocopie du dossier médical et des résultats d'analyses

Le rapport d'autopsie en cas de décès

Communiquer le dossier de l'investigation au comité national d'experts sur les MAPI

Actions correctives

Durant l'enquête, éviter de blâmer des agents et faire preuve d'empathie envers les patients ou leurs parents

A l'endroit de la communauté	A l'endroit des vaccinateurs	A l'endroit des autorités sanitaires
Rassurer la communauté par la voie autorisée Faciliter la prise en charge des cas	Encourager les vaccinateurs à plus de vigilance et au respect des recommandations	Proposer des formations ou une revue des procédures et des outils selon les insuffisances constatées

En dehors des erreurs de vaccination qui peuvent être élucidées lors d'une enquête sur le terrain et nécessitent une action immédiate, se conformer aux délibérations du comité national des experts.

ORIENTATIONS POUR LA PRISE EN CHARGE DES MAPI GRAVES À L'HÔPITAL DE RÉFÉRENCE

La détection de MAPI relève de la suspicion alors que le diagnostic de MAPI est un diagnostic d'exclusion ; ayant recherché toutes les étiologies possibles, rien d'autre que la MAPI n'a pu justifier l'état clinique du patient.

Faites un diagnostic argumenté, détaillé et minutieux et documentez-le au fur et à mesure sur le dossier clinique du malade.

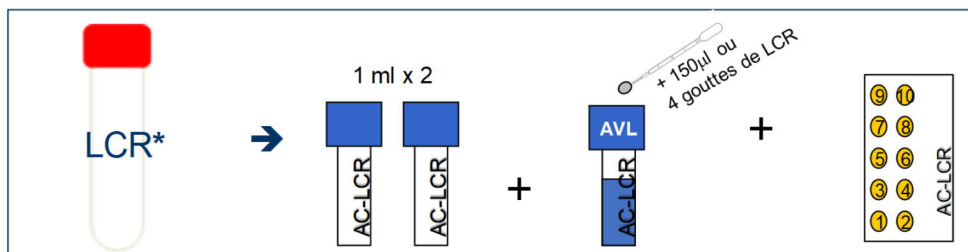
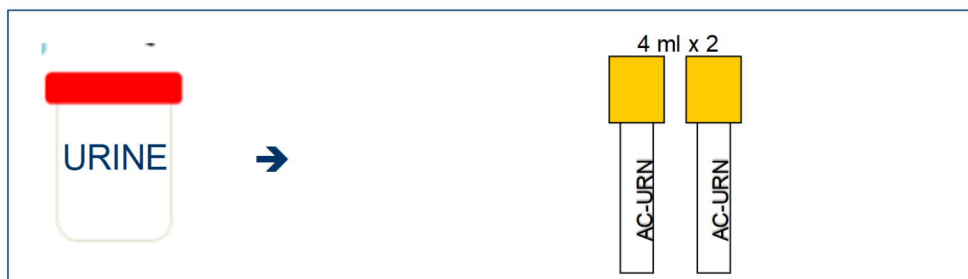
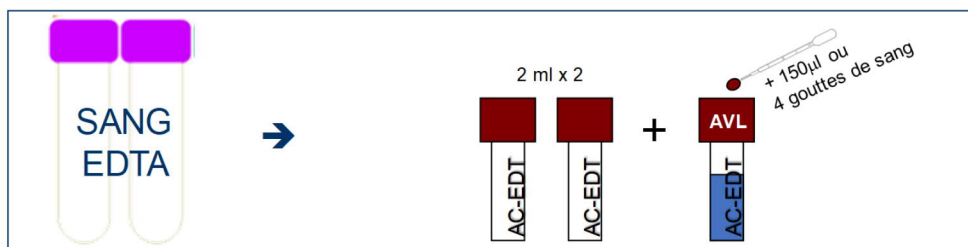
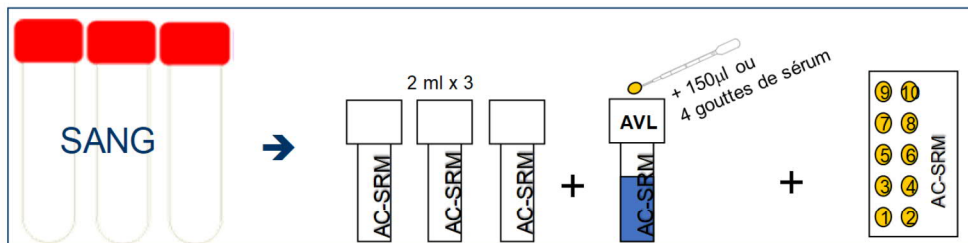
MAPI graves	Définition de cas	Éléments diagnostiques	Diagnostic différentiel/prise en charge
Choc anaphylactique	- Apparition soudaine (et jusqu'à 72h) d'un tableau associant : hypotension artérielle (TAS < 9 mmHg), pouls filant ou imprenable, extrémités froides, hypersudation, troubles de la conscience - Avec ou sans urticaire, prurit, angioedème, détresse respiratoire	- Circonstances de survenue, fréquence cardiaque (bradycardie), NFS, ionogramme, créatininémie, urémie, glycémie, Hémoculture - ECG	- Choc cardiogénique (infarctus) - Choc septique - Choc hypovolémique (hémorragie, diarrhée) - Syncope vaso-vagal - Coma hypoglycémique
Anaphylaxie	Réaction allergique sévère survenant immédiatement ou dans l'heure qui suit la vaccination, caractérisée par une défaillance cardio-circulatoire avec : - Pouls accéléré, filant ou imprenable - Hypotension, Obnubilation, polypnée et pâleur cutanéomuqueuse	- Signes cutanéomuqueux : prurit, urticaire, œdème de Quincke, sueurs... - Signes respiratoires : toux, dyspnée... - Signes cardio-vasculaires : bouffée de chaleur, tachycardie, pouls petit et filant, chute de la tension artérielle... - Examen paraclinique : NFS, urée, créatininémie, glycémie, transaminases, ionogramme sanguin, CRP	- Mise en position allongée du patient, tête basse. - Prise de la TA et du pouls - Oxygénothérapie - Remplissage vasculaire le plus vite possible : SSI (250 ml), - Corticoïdes
Encéphalopathie	<i>Apparition aiguë d'un état morbide caractérisé par une conscience dépressive ou altérée et/ou un trouble du comportement durant un jour ou plus.</i>	Anamnèse, examen physique neurologique NFS, ionogramme, glycémie, Sérologie HIV, num CD4 LCR (ECB, chimie, ± Ag solubles), - EEG, radio rachis, scanner	- Encéphalopathies hépatique, virale, - Hépatite métabolique
Fièvre persistante	Température supérieure à 38°C : - Modérée si température (38°C-38.9°C) - Élevée si (39°C-40.4°C) - Extrême (40.5°C) - Persistante(>24h)	- Température - Durée de la fièvre	- Infections virales (y compris MVE) - Septicémie

Réaction au point d'injection	Réaction inflammatoire sévère au site d'injection, dépassant l'articulation adjacente et caractérisée par l'œdème, la douleur et la chaleur Evolution en deux phases : - Phase inflammatoire : douleur, rougeur, tuméfaction - Phase d'abcès* : Masse fluctuante au point d'injection. L'abcès peut être bactérien (présence de fièvre) ou stérile (absence de fièvre)	- Examen paraclinique - NFS - ECB du pus	Phase inflammatoire : Acide acétylsalicylique : 50mg/kg/J en 3 prises Antibiotique Pansement alcoolisé Phase d'abcès : Antibiotique Sur avis chirurgical : Incision, Drainage, Pansement Si fistulisation : antiseptique local Paracétamol en IV ou en IR
Convulsions fébriles ou répétitives	Secousses tonico-cloniques localisées ou généralisées accompagnées ou non de signes de focalisation ou de signes neurologiques	- Examen physique neurologique - Examen paraclinique - Urée, Créatininémie, NFS, Transaminases, - ECB et biochimie du LCR, - Radio pulmonaire, Scanner cérébral, EEG, - PCR (sang, urine, salive)	- Epilepsie - Paludisme grave (forme neurologique) - Méningite - Toxoplasmose cérébrale - ...
Septicémie	Etat infectieux sévère associant un Syndrome de Réponse Inflammatoire Systémique (SRIS) avec une infection présumée ou identifiée. Le SRIS est l'association d'au moins deux des signes suivants : - Température >38°C ou <36°C - Tachycardie avec FC>120 bat/mn - Polypnée avec FR >20 cycles/mn - Hypotension - Hyperleucocytose >12000/ml ou <4000/ml	Examen clinique : Température, FC, FR, TA Examen paraclinique : - NFS, CRP, Urée, Créatinémie, Transaminases, Ionogramme sanguin, - GE/frottis Hémocultures, ECBU - Echographie abdominale et ou du site infectieux, radio pulmonaire - PCR (sang, urine, salive)	- Hospitalisation - Prise de voie veineuse en urgence - Surveillance dynamique (Pouls, TA, FR, conscience) - Bi antibiothérapie (IV) urgente fonction du site infectieux et du germe suspecté - SSI (250 ml) - Perfusion de macromolécules si hypotension - Oxygénothérapie si dyspnée - Antipyrétique si température >39°C

ORIENTATIONS POUR LE LABORATOIRE DES HÔPITAUX DE RÉFÉRENCE

A. Prélèvements et mise en aliquote

PRELEVEMENTS → ALIQUOTES



Conservation des échantillons: Stockage (-80°C)

Prélèvements en cas de décès —> AUTOPSIE

<=> Ne pas mettre de formol avant le prélèvement

1. Procéder à une ponction cardiaque sur tube EDTA et sur tube sec
2. Alerter le point focal MAPI de département, le DDS et le Comité national des experts MAPI
3. Expliquer le bien-fondé de l'autopsie et requérir l'assentiment du tuteur légal du défunt
4. Informer avec le tact requis, le tuteur légal des dispositions relatives à une autopsie
5. Faire signer la fiche de consentement d'autopsie en double exemplaire
6. Alerter immédiatement le médecin chargé de l'autopsie
7. En cas de refus de l'autopsie, proposer une biopsie d'organes.

Emballage et envoi des prélèvements

1. Ranger dans une pochette transparente les échantillons de même type
 - * pochettes de petite taille : AC-SRM, CV-SRM, SNG, LCR
 - * pochette de taille moyenne : URN
2. Inscrire sur chaque pochette le code patient et le code échantillon
3. Mettre les pochettes contenant les échantillons (une pochette par patient) dans un porte vaccin avec 2 accumulateurs bien congelés
4. Mettre une copie de la fiche d'examens biologiques complètement remplie dans un sachet plastique dans le porte-vaccin
5. Remplir la fiche de transport d'échantillon
6. Sceller le porte-vaccin, l'adresser et le remettre au transporteur avec la fiche de transport qu'il contresigne
7. Communiquer au point focal de laboratoire national de référence : les références du véhicule et du conducteur et l'heure probable d'arrivée.

Réception des échantillons au niveau du laboratoire national de référence

1. Dès notification de l'envoi, faire le suivi jusqu'à la réception
2. Au laboratoire de national de référence:
 - 2a- Remplir la partie grisée du tableau de la fiche d'examens biologiques
 - 2b- Retirer les aliquots nécessaires pour les examens
 - 2c- Remplir la fiche de stockage d'échantillons
 - 2d- Mettre les échantillons SNG au réfrigérateur (+4°C) et les autres échantillons au congélateur (-80°C)
3. Adresser les résultats des analyses effectuées au laboratoire au clinicien de l'hôpital de référence et à l'équipe nationale MAPI.

Notes personnelles

Notes personnelles

RÉPERTOIRE D'ADRESSE DES CONTACTS DIRECTS DANS LA SURVEILLANCE DES MAPI

[illegible]